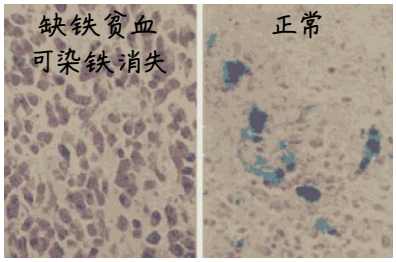
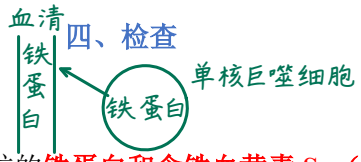
注意：
①进行性吞咽困难：食管癌、肺癌等压迫食管、胃食管反流病并发食管狭窄（胃食管反流病并发症）
②间歇性吞咽困难：贲门失弛缓症、胃食管反流病、Plummer-Vinson 综合征
③感觉咽部有异物感堵塞感、却没有真正的吞咽困难（癔球症）：胃食管反流病食管外症状

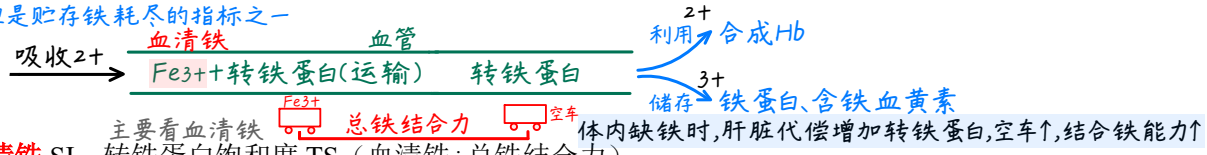


血清铁≠血清铁蛋白(储存铁)
↓ ↓
红细胞内铁缺乏 贮存铁耗尽就开始出现

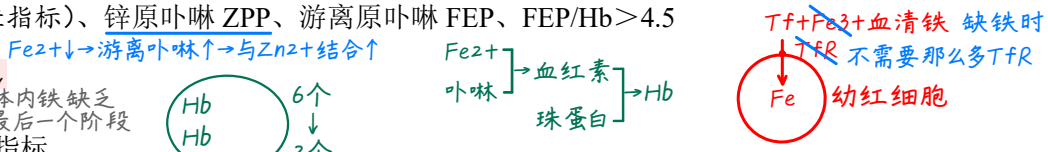
四、检查

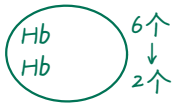


1.**贮存铁的耗尽（潜伏期）**"带大S都↓"
①**血清铁蛋白** SF＜12μg/L（**最敏感**）仓库
②骨髓铁染色示**骨髓小粒可染铁消失**：骨髓小粒的**铁蛋白和含铁血黄素 Su（骨髓细胞外铁）缺乏**（ttsx **最可靠**）
存在单核巨噬细胞系统 骨髓里面幼红细胞外面的铁
③**铁粒幼红细胞（骨髓细胞内铁）**＜15%
骨髓里面含有铁颗粒的幼红细胞
不是贮存铁,是功能铁,但是贮存铁耗尽的指标之一

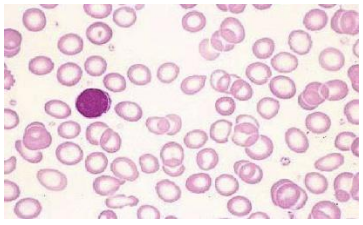
2.**红细胞内铁缺乏**


①有上述异常指标
②**下降**的指标：**血清铁** SI、转铁蛋白饱和度 TS（血清铁÷总铁结合力）
转铁蛋白运输铁的能力
③**升高**的指标：未结合铁的转铁蛋白 TF、**总铁结合力** TIBC、血清可溶性转铁蛋白受体 **sTfR**（反映缺铁性红细胞从RBC膜表面掉落到血浆 sGC可溶性鸟苷酸环化酶
Hb 合成的最佳指标）、锌原卟啉 ZPP、游离原卟啉 FEP、FEP/Hb＞4.5



该阶段才有Hb↓
3.**缺铁性贫血** 体内铁缺乏最后一个阶段


①有上述异常指标
②**小细胞低色素性贫血**：**Hb↓**、平均红细胞体积 **MCV＜80**、平均红细胞血红蛋白量 MCH＜27、平均红细胞血红蛋白浓度 **MCHC＜32%（320g/L）** 三年二班跑 800 米有儿有妻
③外周血涂片见红细胞体积小、中央淡染区**扩大** 严重缺铁影响三系
④RBC 正常或↓，WBC 正常（严重时可↓），**Plt 正常或↑（严重时可↓）**
诊断贫血看Hb数量(早于RBC数量下降) 慢性失血时代偿性↑





转铁饱和度↓,总铁结合力↑

五、治疗

1.病因治疗最根本：如胃肠道出血者应多次查大便隐血、必要时影像学或内镜；月经过多者应检查有无妇科疾病

2.一般**不**需要输血，必要时可输浓缩红细胞
给一点铁就可以纠正贫血

3.首选有机铁：右旋糖酐铁、琥珀酸亚铁、富马酸亚铁、葡萄糖酸亚铁、山梨醇铁、多糖铁复合物
次选无机铁:硫酸亚铁FeSO4

4.首选口服铁（注射可能引起过敏反应）$Fe^{3+} \xrightarrow{VitC} Fe^{2+}$
①可与 **VitC**（溶解状态）、**稀盐酸**同服以**增加铁的吸收**（利于还原）（而进食谷类、乳类、茶会抑制铁的吸收）谷乳茶
②口服效果不佳可肌肉注射：剂量=（需达到的血红蛋白浓度-病人的血红蛋白浓度）×0.33×体重
消化性溃疡致缺铁贫治疗:不能与稀盐酸同服(注意关注病因)

5.补铁后相关指标（咏铁：网红十日高峰立、血红蛋白 2 周起、2 月正常别着急、半年才能停铁剂）
①**最先升高（评价补铁是否有效）：Ret**（在 5-10 天达高峰）Ret是血液系统的小宝藏(必看)
②**Hb 2 周后开始升高**、2 月左右恢复正常
③Hb 正常后继续补铁 4-6 个月、待**铁蛋白正常后停药**（仓库）
血清铁蛋白缺铁时最先被掏空,最后被补齐

